

2

乳がん:薬剤師の実践ポイント

長期治療を支えるアドヒアランス支援

1 服薬指導で伝えるポイント



内分泌療法は長期間の服薬になるため、飲み忘れ防止の工夫(お薬カレンダー等)を提案する



抗HER2療法・アントラサイクリン系使用者に、息切れ・むくみ等の心不全兆候を伝える



CDK4/6阻害薬服用中は発熱時の速やかな連絡を徹底する(骨髄抑制)

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ タモキシフェン使用者でCYP2D6阻害薬(一部のSSRI等)との併用がないか確認する
- ☐ 抗HER2療法・アントラサイクリン系併用歴がある患者の累積心毒性リスクを確認する
- ☐ CDK4/6阻害薬とCYP3A4関連薬剤の相互作用を確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



内分泌療法の長期フォロー(骨密度検査等)の実施状況を医療機関間で共有する



心機能評価のスケジュールを乳腺外科・循環器内科と共有する

4 実践チェックリスト

- ☐ サブタイプに応じた治療かどうかを処方内容から確認し、重点モニタリング項目を意識する
- ☐ 内分泌療法の長期アドヒアランスを定期的に確認する
- ☐ 心毒性リスクのある治療歴を通算で把握し、新たな治療追加時にリスクを再評価する

乳がん治療は年単位で続く内分泌療法が鍵を握る。長く付き合う薬だからこそ、アドヒアランス支援が薬剤師の腕の見せどころ。